مركز د. سلام جبريل لأمراض النساء والولادة وأطفال الأنابيب:

مواكبة التطورات المتسارعة في تقنية «أطفال الأنابيب» .. والجودة مبدؤنا

يقوده ويديره استشاري متميز له باعه الطويل في هذا المجال، وخبرته الواسعة التي أفرح بها قلوب العديد من الأسر وتحقيق أحلامها بالإنجاب بعد طول انتظار ومعاناة، وذلك بمشيئة الله ومن ثم بالعطاء والجهود ومواكبة التطور المتسارع في عالم الطب و«أطفال الأنابيب» .. لاشك أننا هنا نتحدث عن مركز د. سلام جبريل لأمراض النساء والولادة وأطفال الأنابيب الذي لمع اسمه في هذا المجال نظراً لما يقدمه من جودة في العلاج مع سرية مطلقة ومحافظة على الخصوصية التي هي من كرامة المرضى، هكذا يدير الدكتور سلام مركزه الذي افتتحه في العام 2017 في شارع الخدمات بالقرب من «كوبري الخارطة» .. «ليالينا» زارته في المركز وتناولت معه العديد من الموضوعات ذات الشأن بالمركز وبأطفال الأنابيب:

مركز د. سلام يُدخل تقنية جديدة عبارة عن حاضنة تضم 6 حُجرات لمراقبة 16 جنينياً كل 10 دقائق

نحب أن نعرّف القارئ بنبذة يسيرة عنك دكتور؟

دكتور سلام جبريل، استشاري أول في أمراض النساء والتوليد والعقم وجراحة المناظير النسائية، أستاذ في جامعة الخليج العربي في كلية الطب، أدرس مادة النسائية والتوليد، درست في الأردن، وأكملت دراساتي العليا في ألمانيا، وبعدها عملت لعدة سنوات في كل من الاردن والمملكة العربية السعودية واليمن ومملكة البحرين، متزوج ولدي 3 أولاد، ولدان وبنت واحدة، الأول طبيب جرّاح، والثاني طبيب في الأمراض النسائية، ولدي بنت مهندسة معمارية.

مذ متى تم افتتاح مركز دكتور سلام جبريل في الموقع الحالي له؟

تم افتتاح المركز في نهاية عام 2017، حيث بدأنا بعيادة في أول الأمر حتى حصلنا على الترخيص الرسمي من مؤسسة التراخيص (نهرا)، وبعدها بدأنا بإجراء عمليات أطفال الأنابيب في المركز هنا بكل مراحها والخطوات التي تؤدي في النهاية إلى النتائج المرجوة وهي الوصول إلى التخصيب ووقوع الحمل في مختلف الحالات.

ما آخر التطورات بشأن علاجات وتقنيات أطفال الأنابيب والتوليد بشكل عام؟

فيما يتعلق بأطفال الأنابيب فإنها قد قطعت شوطاً كبيراً منذ أن بدأت في بداية السبعينيات من القرن الماضي وحتى الآن، فمع أول ولادة لأطفال الأنابيب - التي كانت في بريطانيا في مستشفى بورن هول - بدأت مرحلة تطورات كثيرة شملت الدواء، وطبيعة الدواء، والعلميات التي تؤدي بالتالي إلى الإخصاب خارج الجسم والتي تعرف بتقنيات أطفال الأنابيب، وقد حدث في ذلك اختراق نوعي في مطلع التسعينيات بتقنية الحقن المجهري والتي ساعدت كثيراً من الرجال أيضا وليس النساء فحسب للإنجاب عبر هذه التقنية التي تطورت اليوم كثيراً، ومن ضمن التطورات الحاصلة في أطفال الأنابيب هي التقنيات في المجال الوراثي، والتأكد من سلامة الجنين قبل إرجاعه، ومعالجة بعض الأمراض الوراثية مثل السكلر والثلاسيميا، والأمراض الاستقلابية، حيث أن هذه الأمراض ساعدت تقنيات الوراثة باستبعاد الأجنة المصابة والحصول على أجنة سليمة، وبالتالي وفّرت على أهل هؤلاء الأطفال علاجهم ما بعد الولادة، بل وفرّت على الدول أيضا في هذا المجال.

التقنيات الحديثية التي تستخدم الآن في مجال أطفال الأنابيب تهدف للوصول إلى الجنين السليم الذي يعطي نتائج حمل مرتفعة، وبذلك تكون محاولات الحمل أقل فشلاً، وطبعاً لا يوجد حالات يحصل الحمل فيها 100 % لعوامل متعددة لا زلنا في بعض الأحيان نجهل أسبابها، وتدخل الأسباب المناعية بالدرجة الأولى في الحالات التي تفشل فيها عمليات الحمل في أطفال الأنابيب، والآن ظهرت تقنيات حديثة في تحديد مثل هذه العوامل التي تؤدي بالتالي إلى عدم قبول الجنين والتصاقه بجدار الرحم، وقد تم تطوير فحص جديد لمعرفة الوقت المناسب في إرجاع الجنين حتى تم تحديد ما يعرف بـ(نافذة الانغراس) وهو الوقت الذي ينغرس فيه الجنين في داخل جدار الرحم، ونحن في هذا السياق نقوم بأجراء هذا الفحص المطوّر في مركز د. سلام جبريل لأطفال الأنابيب، والنتائج بعد إجراء هذا الفحص للذين حاولوا وتكررت لديهم محاولات الفشل في الحمل كانت ممتازة، ونكاد نقول أن أكثر من نصف المرضى بعد تحديد نافذة التصاق الجنين داخل الرحم تمت بنجاح في أطفال الأنابيب.

دكتور، هل هناك دراسة حول معرفة أسباب العقم لدى الرجال او النساء؟

عملت أنا في أكثر من دولة خلال مسيرتي الطويلة في مجال أطفال الأنابيب، ولاحظت أن عقم الرجال في منطقة الخليج لا يستهان به كنسبة من النسبة العامة في منطقة الشرق الأوسط قاطبة، وأحياناً نحن نستهجن ونستغرب مثل هذه النسب، لكن التطور الصناعي في الحياة عموماً أدى في الكثير من الأحيان إلى انخفاض خصوبة الرجال في القرن العشرين، والسبب هو استعمال المواد الكيماوية التي تفرز مواد تؤثر سلبا على الهرمونات في جسم الرجل، مثل المواد البلاستكية التي تؤدي إلى زيادة هرمون الأستروجين عند الرجل (وهو هرمون أنثوي)، فتؤثر سلبا على انتاجية الخصية من الحيوانات المنوية ومن نوعيتها وخصوبتها، وهذه بالدرجة الأولى التي تؤثر هرمونيا على الرجل.

كذلك بالنسبة إلى نوعية الحيوانات المنوية من حيث جودتها وسلامتها وحركتها، فإنها تتأثر بطبيعة الغذاء وطبيعة الجو الحار، وبطبيعة العمل والتعرض للمواد الكيماوية المؤثرة على الخصوبة، والتعرض للمواد الإشعاعية، والبيئة المحيطة بالشخص الذي لديه مشكلة في العقم أو مشكلة في انتاج الحيوانات المنوية أحياناً. ووجدنا أن الكثير من المواد الكيماوية التي تستخدم في المبيدات الحشرية في بعض الدول تؤدي إلى عقم الرجال بشكل كبير أيضا.

وماذا عن أسباب العقم لدى النساء؟

عقم النساء بالدرجة الأولى نلاحظه في أن الكثير من النساء يعانين من الاضرابات في الهرمونات، كما أن زيادة نسبة العمليات الجراحية تؤدي أحيانا إلى زيادة الالتصاقات فتودي إلى انسداد الأنابيب، وهذا هو السبب الرئيسي الذي جاءت تقنية أطفال الأنابيب نتيجة له، فحصول مثلا الحمل خارج الرحم في الأنابيب واستئصال هذه الأنابيب يبقى الخيار الوحيد أمام الزوجة أن تلجأ لأطفال أنابيب حتى تتمكن من الإنجاب، والظاهرة العالمية الملاحظة عموماً وليست مقتصرة على منطقتنا فحسب هي السمنة وارتفاع الوزن لدى الرجال والنساء على حد سواء، وفي الحالتين تتأثر الزوجة بهذا ويتأثر الزوج أيضا، فالمرأة تتأثر نتيجة زيادة الوزن الذي يؤدي لضعف التبويض، ويؤدي بالتالي إلى حدوث صعوبة في الحمل، وفي كثير من الأحيان تنتهي العديد من الحالات بتدخل تقنية أطفال الأنابيب، وكذلك بالنسبة للرجال، فزيادة الوزن تؤدي إلى انتاج هرمونات تضعف من إمكانية انتاج الخصية للحيوانات المنوية عدداً وحركة ونوعية، وتؤثر على الإخصاب.

ماذا عن العامل الوراثي، هل له علاقة في مسألة العقم سواء بالنسبة للرجال أو النساء؟

نعم، العامل الوراثي مهم بالنسبة للرجال والنساء، فبالنسبة للرجل الذي لديه ضعف في انتاج الحيوانات المنوية نجد أن

> تطوّر التقنيات في المجال الوراثي والتأكد من سلامة «جنين الأنابيب» قبل إرجاعه

سريّة تامّة في علاج كل المرضى بلا استثناء، وأشد الحرص على الخصوصية

أولاده أيضا يعانون من نفس المشكلة في مسألة الإنجاب، وفي بعض الحالات نلحظ أن 3 أو 4 من الإخوة لديهم نفس المشكلة في الإنجاب وضعف الحيوانات المنوية، وجميعهم يحتاجون في النهاية إلى تقنية طفل الأنابيب من أجل الإنجاب. وكذلك الأمر بالنسبة للنساء، فالعامل الوراثي له علاقة أيضا، لأن العديد من الحالات التي تتعرض لإضرابات هرمونية، فبعضها موروث، وإن كان مورثاً بشكل غير واضح، فليس هناك اختراق جيني وراثي كامل في مثل هذه الحالات، لكن تظهر في بعض البنات من ناحية الأم ولا تظهر في البعض الآخر، وهنا أيضا يستدعي الأمر تدخل تقنية أطفال الأنابيب.

كيف يتم تحديد العلاج لكل حالة من هذه الحالات؟

في البداية نشترط أن يحضر الزوجان معاً حتى تكون الأمور واضحة ومتوازية بالنسبة للزوج والزوجة، لا نريد أن نبدأ بعلاج الزوجة مثلا ومن ثم نعود بعد فترة لنكتشف أن السبب هو الزوج، فبالنسبة للرجل فالفحص سهل وبسيط عبر أخذ عينة للمختبر والكشف عليها من حيث الحيوانات المنوية عدداً ونوعية وحركة والأشكال الطبيعية لها، وكل ذلك يعطينا فكرة أساسية عن نسبة التأخر في الحمل بسبب الرجل أو المرأة.

نقوم بعد هذه المرحلة بإجراء فحوصات للهرمونات وفحص السونار للخصية، وفي بعض الأحيان أخذ عينات من الخصية تحت التخدير للكشف عن وجود الحيوانات المنوية من عدمها.أما بالنسبة للمرأة، نبدأ بالتعرف على السيرة المرضية لها، هل الدورة الشهرية لديها منتظمة أم لا؟ هل هناك تأخر أو زيادة؟ هل تعاني من آلام مصاحبة للدورة؟ وغيرها من الأمور التي نستطيع من خلالها رسم خارطة واضحة لنعرف أين نتجه في الفحص والعلاج، وبعدها يتم إجراء صورة بالسونار لمعرفة وضع الرحم والمبيض حتى نكتشف إن كان ثمة ضعفاً في إنتاج البويضات أو قلة أو أن الأمر طبيعي، فربما توجد أحيانا بويضات بشكل كثير، ثم ننتقل لإجراء الفحوصات الهرمونية، وهي غالباً ما تكون في اليوم الثالث من الدورة الشهرية حتى نصل إلى المعدل الهرموني الأساسي عند كل امرأة، وبالتالي نتعرف على معدل الهرمونات في جسم المرأة في الغدة النخامية التي تعمل على انتاج البويضات. وكذلك الهرمونات الموجودة في الغدة الدرقية والتي هي من أهم المنظمات لعملية الأيض في داخل الجسم، ومعرفة الهرمونات الموجودة في الغدة الفوق كلوية، وفي النهاية نصل إلى الهرمونات الموجودة في المبيض، فكل هذه يعرفنا إن كان هناك أي اختلال الهرموني، وبناء عليها يتحدد العلاج.

وإذا وجدنا أن هناك عمليات جراحية سابقة تم إجراؤها، فيفضل أن تجرى صورة ظليليه ملونة حتى نتأكد إذا كانت الأنابيب داخل الرحم سليمة أم لا، وهذا مهم لاكتشاف إن كان هناك خللا في الأنابيب، كذلك إجراء منظار لداخل الرحم للتأكد من سلامة الرحم من الداخل لوضع الأجنة، وعمل منظار لداخل البطن ليعرفنا على وجود أي التصاقات داخل الرحم أو أي سبب معطل للتخصيب الطبيعي أو أمراض معينة مثل بطانة الرحم المهاجرة التي يمكن أن تكون سبباً في عدم الإنجاب في كثير من الأحيان.

هل يكون العلاج دوائيا غالباً، ام ربما تكون هناك تدخلات جراحية لبعض الحالات؟

بعد التعرف على أين الخلل، يبدأ العلاج دائماً بالدواء البسيط في المرحلة الأولى، وهي علاجات تمكننا من إعطاء الفرصة للزوجين بالإنجاب طبيعياً من خلال مراقبة التبويض أو من خلال إعطاء بعض العلاجات المساعدة في استيفاء ما هو متطلب للإنجاب الطبيعي، فإذا كان هذا المستوى من العلاج غير مفيد، فنلجأ إلى عمليات مساعدة على الحمل بإجراء حقن السائل المنوي داخل الرحم بعد التأكد من كل الأسباب الأخرى التي تعيق الحمل، وإذا وجدنا أن هناك احتمالية لسبب معطل جراحي، نقوم بإجراء عمليات جراحية مثل المنظار ومثل استئصال الألياف أحياناً من الرحم، وهذه العمليات الجراحية سواء داخل الرحم أو البطن كثيراً ما تساعد في التجنب من القيام بتقنية أطفال الأنابيب كونها آخر مراحل العلاج بالحقن المجهري.

نظراً لحساسية الأمر، ما مدى السرية في التعامل من هذه الحالات الزوجية؟

دائماً لدينا سرية تامة في علاج كل المرضى بلا استثناء، حتى في الأمور العادية البسيطة، فضلاً عن عملية أطفال الأنابيب

طبيعة الغذاء والجو والتعرض للمواد الكيماوية تؤثر على الخصوبة لدى الرجل

التي لا يرغب الكثيرون في أن يعرف أحد أنهم يقومون بذلك، لدرجة أن أحد مرضاي أجنب ثلاثة أطفال والأطفال كبروا بينما أقرب الناس لهم لم يعرفوا أنهم أطفال انابيب، فالسرية هي حقٌ أساسي للزوجين، وفي كل الأحيان نراعي مثل هذا الموضوع لحساسيته، ونعتبر ذلك من كرامة المريض الذي يزورنا.

هل للعمر علاقة في مسألة الإنجاب سواء للزوج أو الزوجة عن طريق الأنابيب؟

يفضل أن يكون العمر صغيراً، حتى يستغل الزوجان الفرصة للإنجاب، ونعرّف العمر الصغير طبيا بأقل من 35 عاماً للمرأة، وحتى في عمر الأربعين أحياناً تكون الأمور بخير وجيدة، لأن جودة البويضات عند المرأة تتراجع تدريجياً بعد عمر الـ38 عاماً بحسب ملاحظتنا، مع العلم أن هناك مرضى ما زالت لديهم جودة في البويضات حتى بعد سن الـ45، ولدينا حالات أنجبت الأمهات أطفالا سليمين في عمر الـ45 تقريباً، و20 % من النساء اللواتي يقمن بعملية أطفال أنابيب في مركز د. سلام جبريل عمرهن يزيد عن الأربعين، وهذا التغيّر عالمي، نظراً لتزوّج النساء في أعمار متأخرة، والإنجاب يتأخر.

أما بالنسبة للرجال، فالعمر له تأثير أقل، لكن دون شك أن عدد الحيوانات المنوية وجودتها تتناقص وتتضاءل مع مضي العمر، لكن تختلف الأمور بالنسبة للمرأة، حيث أن الرجل ينتج ملايين الحيوانات المنوية، بينما المرأة تنتج بويضة واحدة كل شهر، فهذا هو الفارق الكبير في الإنتاجية يجعل فرص الحمل عند الرجال تمتد حتى السبعينات من العمر.

كلمة أخيرة؟

أدخلنا في مركز د. سلام جبريل تقنية جديدة تسمى الامبريوسكوب او ما يعرف بالتايم لابس وهو عبارة عن حاضنة تحتوي 6 حُجرات، كل حجرة مفصولة لمريضة معينة، وهذه الحجرات يمكن أن يوضع فيها مجموعة من الأجنة، في حدها الأعلى 16 جنيناً، ونراقب هذه الأجنة من لحظة تخصيبها حتى 5 أيام متتالية، ويتم تصويرها كل 10 دقائق، وبعد 5 أيام ندرس هذه الأجنة ونأخذ منها الأجنة المتميزة والجيدة، ونعديها إلى داخل رحم الأم، فهذه التقنية حسّنت كثيراً من فرص الحمل في ما يعادل 26 % خلال السنتين الماضيين، وهذا الجهاز نحن متميزون به في البحرين، ونحن أول من أدخل هذه التقنية للبحرين، ونفخر أن ذلك ساعد الكثير من مرضانا في الإنجاب.